RAPPORT DE DUE DILIGENCE ▪ BIOTECH COMMERCIALE ▪ IMMUNO-ONCOLOGIE

ImmunityBio

NASDAQ : IBRX | ANKTIVA® (nogapendekin alfa inbakicept)

Un vrai produit, une vraie croissance — et un cours qui escompte déjà le scénario haussier

Analyse fondamentale, clinique et quantitative : rNPV par segment, analyse bayésienne de QUILT-2.005, scénarios probabilisés, M&A et matrice des risques. Modèle Python (21 figures) joint.

Date : 15 octobre 2026 ▪ Données de marché au 14/10/2026

$10.32	$10.9 Md	$357.4 M	$5.49	-47 %
Cours	Capitalisation	Trésorerie (30/06)	Valeur pondérée	Potentiel

Ventes nettes T2-26 : $50,7 M (+92 % a/a) | VE/ventes 2026E : 54x | Recommandation : NEUTRE / SOUS-PONDÉRER

Table des matières

1 Executive Summary **2**

2 Le produit : ANKTIVA, superagoniste IL-15 **3**
2.1 Mécanisme d'action . . . 3
2.2 Modèle économique . . . 4
2.3 Statut réglementaire . . . 4
2.4 Données cliniques et avantage concurrentiel . . . 5

3 Analyse quantitative **6**
3.1 QUILT-2.005 : lecture bayésienne de l'intérim . . . 6
3.2 Puissance et probabilité de succès (PPoS) . . . 7
3.3 Sensibilité de la valorisation . . . 8

4 Marché & concurrence **8**

5 Analyse M&A **10**

6 Financials **11**

7 Valorisation **13**
7.1 Méthodologie rNPV . . . 13
7.2 Scénarios probabilisés . . . 15

8 Risques **16**

9 Catalyseurs **17**

10 Conclusion **18**

Sources **18**

1 Executive Summary

Thèse d'investissement

- **Exécution commerciale réelle** : ANKTIVA a généré $113 M de ventes nettes en 2025 (+700 %) et $94,8 M au S1-2026 (+121 %), avec 8 trimestres consécutifs de croissance séquentielle.
- **Dérisquage réglementaire majeur le 14/10/2026** : la FDA a étendu le label au papillaire seul BCG-réfractaire, 12 semaines avant le PDUFA (6/1/2027), sans essai randomisé supplémentaire.
- **Prochain binaire** : QUILT-2.005 (BCG-naïf, $n = 366$), sBLA attendue fin 2026 ; l'intérim (RC maintenue 9 mois 84 % vs 52 %, $p = 0{,}046$) donne $P(\Delta > 0) = 98.2\,\%$ mais une PPoS réaliste de $\approx 60\,\%$.
- **Valorisation exigeante** : VE ≈ $11.5 Md, soit 54x les ventes 2026E. Notre rNPV de base ressort à **$4.56/action diluée** ; la valeur pondérée des scénarios à **$5.49** (-47 %).
- **Le cours implique** un pic de ventes ajusté du risque de ≈$6,1 Md, soit 2.38x notre cas central ($2.58 Md) — c'est-à-dire un succès quasi certain en BCG-naïf *plus* une validation de la plateforme hors vessie.
- **Verdict** : société de qualité croissante, action surcotée à court terme. Neutre / sous-pondérer ; exposition spéculative ≤1 % uniquement, de préférence via options après la lecture QUILT-2.005.

Table 1 – Snapshot corporate (sources : 10-Q T2-2026, 8-K du 04/08/2026, cotations Nasdaq)

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Cours (14/10/2026)	$10.32	**Plus bas / haut 52 sem.**	$1.95–12.43
Actions en circulation (31/07)	1,060 M	**Actions diluées (est.)**	1,263 M
Capitalisation (base)	$10.9 Md	**Capitalisation diluée**	$13.0 Md
Trésorerie + titres (30/06)	$357.4 M	**Note conv. Nant (principal)**	$480 M @ $5,427
Passif RIPA Oberland (31/03)	$404 M	**Valeur d'entreprise**	$11.5 Md
Ventes nettes T2-26	$50,7 M (+92 %)	**Ventes S1-26**	$94,8 M (+121 %)
Perte opérationnelle T2-26	$61,7 M	**Perte nette T2-26 (GAAP)**	$230,4 M
Cash consommé opérations S1-26	$141,9 M	**Objectif analystes (moy.)**	$12,6–14,2

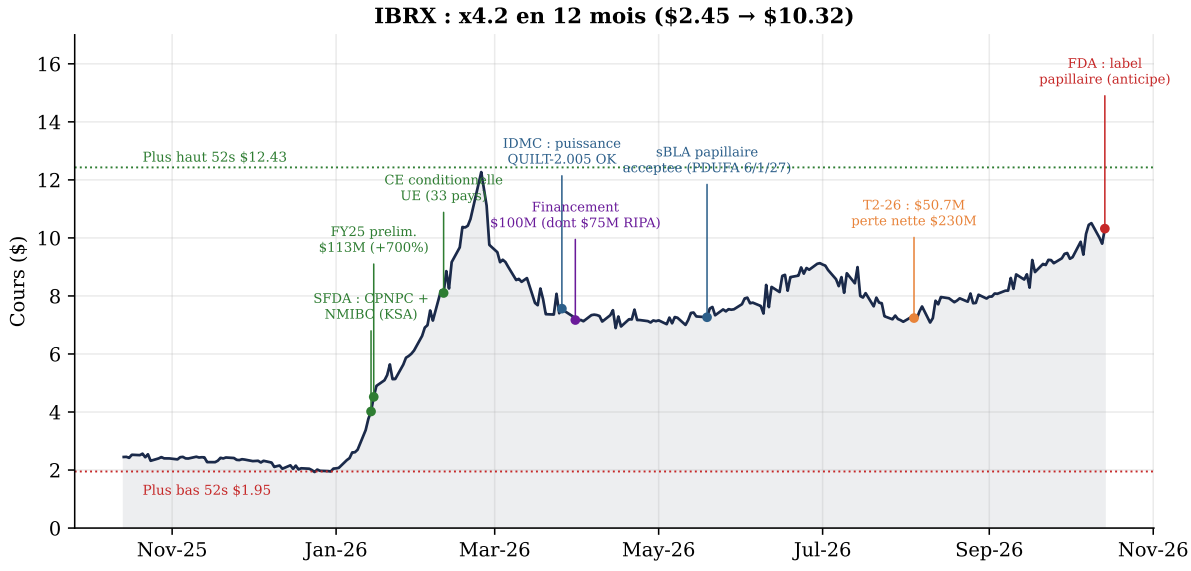


Figure 1 – **Cours IBRX sur 12 mois et catalyseurs annotés.** Trajectoire journalière reconstituée à partir des clôtures publiées (mensuelles et ponctuelles : 2,44 $ le 21/10/25 ; 1,95 $ le 30/12/25 ; 9,28 $ le 01/10/26 ; 10,51 $ le 09/10/26 ; 9,80 $ le 13/10/26 ; 10,32 $ le 14/10/26) par pont brownien entre points d'ancrage. Le titre a été multiplié par ∼4 ; l'essentiel du mouvement (+209 % en janvier, +60 % en février) est intervenu sur la publication des ventes 2025 et les autorisations UE/Arabie saoudite. Depuis mars, le titre consolide entre 7 et 10 $ malgré la croissance — signe que le marché avait déjà intégré une large part des bonnes nouvelles.

2 Le produit : ANKTIVA, superagoniste IL-15

2.1 Mécanisme d'action

ANKTIVA (N-803) est un complexe de fusion IL-15N72D : IL-15Rα-Sushi/Fc-IgG1. La mutation N72D augmente l'affinité pour le récepteur IL-2/15R$\beta\gamma$; la pré-association au domaine sushi de l'IL-15Rα reproduit la *trans-présentation* physiologique et le fragment Fc allonge la demi-vie. Contrairement à l'IL-2, la molécule ne lie pas CD25 et n'expanse donc pas les lymphocytes T régulateurs. En intravésical, elle est co-administrée avec le BCG : le BCG active l'immunité innée, ANKTIVA amplifie la prolifération et la cytotoxicité des cellules NK et des lymphocytes T CD8$^+$ mémoire.

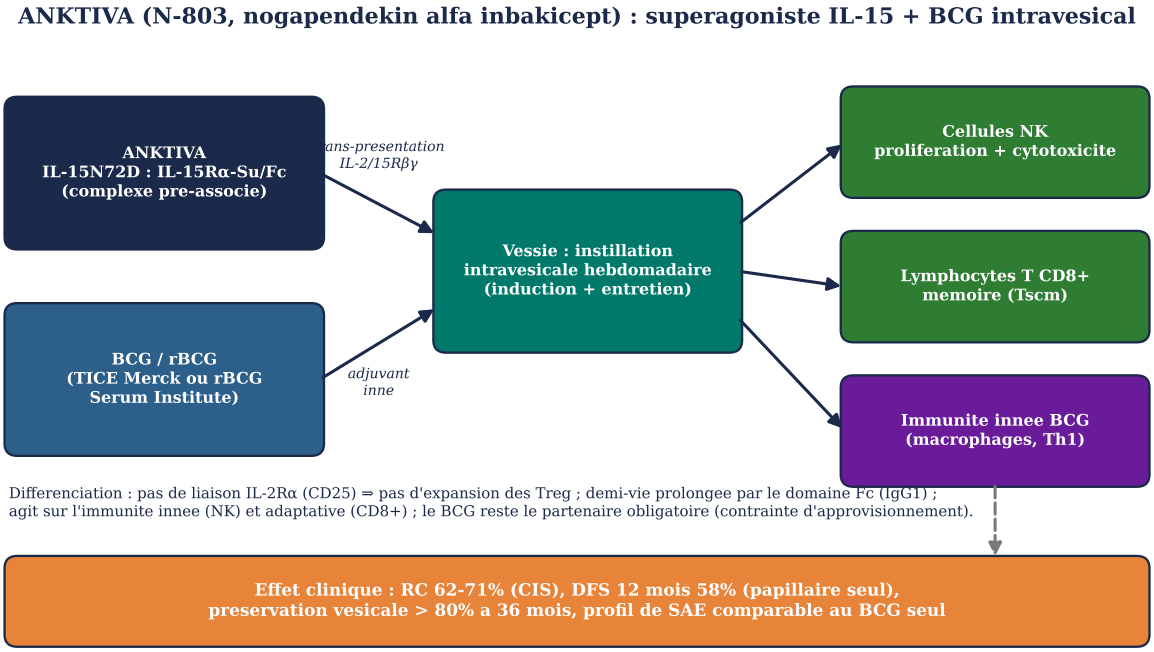


Figure 2 – Mécanisme d'action ANKTIVA + BCG. Les deux agents sont instillés dans la vessie (induction hebdomadaire puis entretien). L'IL-15 superagoniste agit sur les compartiments NK et CD8$^+$; le BCG fournit le signal inné. L'efficacité (RC 62–71 % en CIS ; DFS à 12 mois 58 % en papillaire) provient de QUILT-3.032 (cohortes A et B). Point faible structurel : la dépendance au BCG, en pénurie aux États-Unis depuis 2019.

2.2 Modèle économique

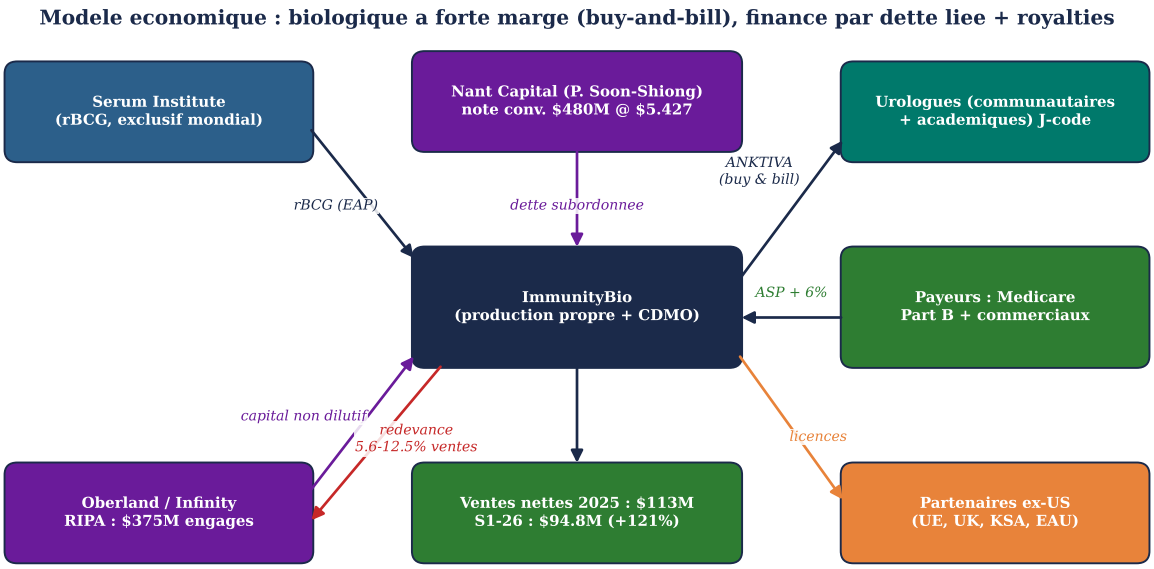


Figure 3 – **Flux économiques.** ANKTIVA est distribué en *buy-and-bill* auprès des urologues, remboursé principalement via Medicare Part B (ASP + 6 %). Le financement repose sur deux piliers non dilutifs mais coûteux : la note convertible subordonnée de Nant Capital (entité de P. Soon-Shiong, $480 M convertibles à $5,427) et le contrat de *revenue interest* (RIPA) avec Oberland/Infinity, porté à $375 M en mars 2026, qui prélève 5,625–12,5 % des ventes mondiales hors Chine. L'approvisionnement en rBCG repose sur un accord exclusif mondial avec le Serum Institute of India (programme d'accès élargi).

2.3 Statut réglementaire

Table 2 – Autorisations et soumissions ANKTIVA (au 15/10/2026)

Juridiction	Indication	Statut / date
FDA (US)	NMIBC BCG-réfractaire avec CIS ± papillaire	Approuvé avril 2024
FDA (US)	NMIBC BCG-réfractaire **papillaire seul** (haut grade)	**Approuvé 14/10/2026** (PDUFA 6/1/2027)
MHRA (UK)	NMIBC CIS BCG-réfractaire	Approuvé juillet 2025
SFDA (Arabie s.)	NMIBC + CPNPC métastatique (avec ICI), accélérée	Approuvé janvier 2026
Commission européenne	NMIBC CIS (conditionnelle, 30 pays EEE)	Approuvé février 2026
Émirats arabes unis	NMIBC	Approuvé juillet 2026
FDA (US)	NMIBC haut risque **BCG-naïf** (QUILT-2.005)	sBLA guidée fin 2026
FDA (US)	CPNPC 2L+ (ResQ201A, confirmatoire)	Recrutement en cours

Contexte : un historique FDA mouvementé

2023 : lettre de réponse complète (CRL) liée aux inspections de fabrication tierce partie. Avril 2024 : approbation CIS. Mai 2025 : *refuse-to-file* sur l'indication papillaire, la FDA exigeant un essai randomisé car la DFS est un critère *time-to-event*. Janvier–mars 2026 : discussions, resoumission avec suivi long terme. Octobre 2026 : approbation par extrapolation CIS → papillaire, sans nouvel essai. Ce revirement réduit le risque réglementaire perçu, mais l'historique montre que la relation avec l'agence reste un facteur de volatilité.

2.4 Données cliniques et avantage concurrentiel

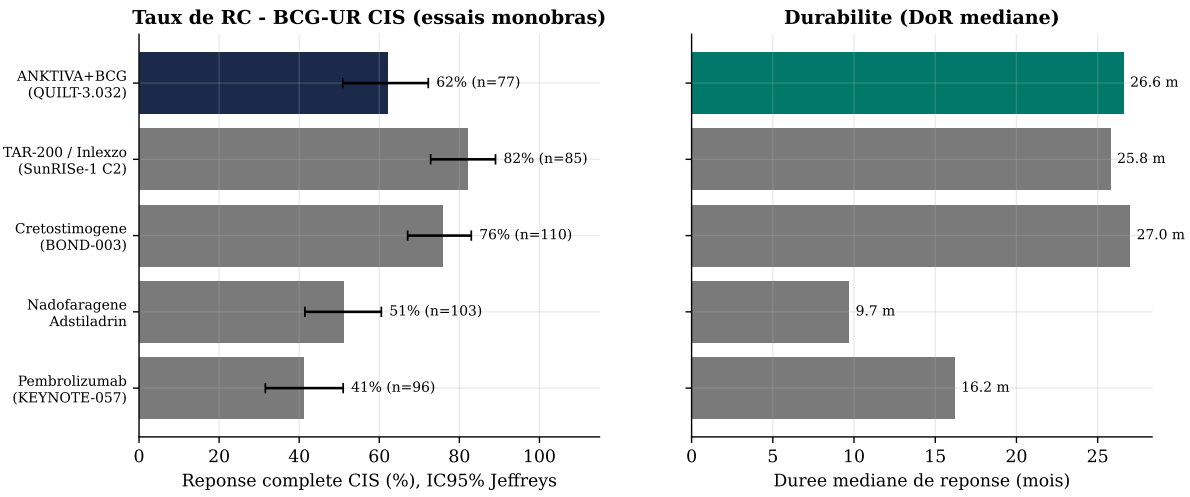


Figure 4 – Comparaison des données pivotales en NMIBC BCG-réfractaire avec CIS. Gauche : taux de réponse complète avec intervalles de confiance à 95 % (Jeffreys, Beta($x+\frac{1}{2}$, $n-x+\frac{1}{2}$)). Droite : durée médiane de réponse. Sources : labels FDA et publications pivotales (QUILT-3.032, SunRISe-1 cohorte 2, BOND-003, essai Adstiladrin de phase 3, KEYNOTE-057). Essais monobras non comparables directement (critères d'inclusion, réinduction autorisée pour ANKTIVA). ANKTIVA domine pembrolizumab et nadofáragène mais **n'est pas le leader en taux de RC** : TAR-200 (Inlexzo, J&J, approuvé septembre 2025) affiche 82 %, crétostimogène 76 %. L'avantage d'ANKTIVA réside dans la durabilité (DoR médiane >26 mois), la préservation vésicale et l'absence de dispositif intravésical.

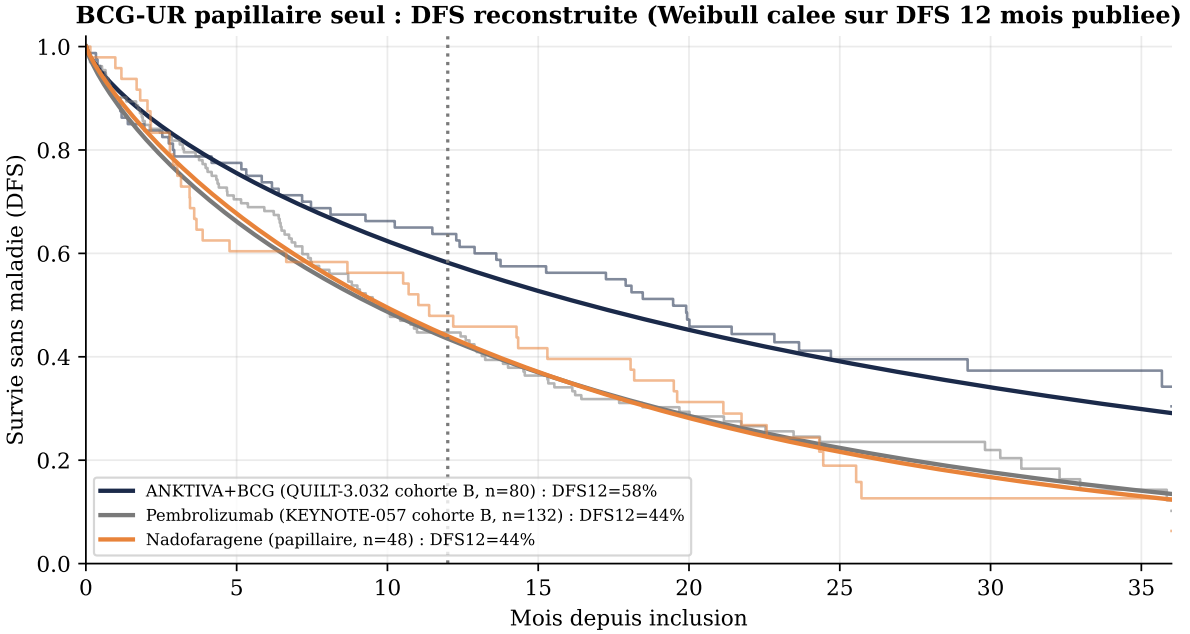


Figure 5 – Survie sans maladie en papillaire seul BCG-réfractaire (courbes reconstruites). Modèle de Weibull $S(t) = \exp[-(t/\lambda)^k]$ calé sur la DFS à 12 mois publiée (ANKTIVA 58,2 %, *J. Urol.* ; pembrolizumab KEYNOTE-057 cohorte B 43,5 % ; nadofáragène 44 %), avec $\lambda = 12/(-\ln S_{12})^{1/k}$ et un paramètre de forme $k \in [0{,}75; 0{,}85]$ (risque décroissant). Les escaliers sont des cohortes simulées de même taille avec censure administrative uniforme 18–48 mois. Il s'agit d'une illustration, pas de données individuelles ; elle montre toutefois que l'écart de ∼14 points à 12 mois se maintient dans le temps sous des hypothèses raisonnables.

Avantages compétitifs défendables

1. **Durabilité** : 58 % des répondeurs CIS en RC à ≥12 mois ; préservation vésicale >80 % à 36 mois et survie spécifique 96 % en papillaire.
2. **Simplicité d'usage** : instillation liquide standard (vs dispositif intravésical TAR-200 ou vecteur viral), compatible avec la pratique des urologues communautaires.
3. **Label le plus large** en BCG-réfractaire depuis le 14/10/2026 (CIS *et* papillaire seul) — J&J doit encore produire l'essai SunRISe-5 pour le papillaire.
4. **Optionnalité en amont** : essai randomisé pivot déjà entièrement recruté en BCG-naïf (le segment le plus large du NMIBC), en concurrence de calendrier avec SunRISe-3 (J&J) et POTOMAC (AstraZeneca).
5. **Protection** : exclusivité biologique de 12 ans (jusqu'à ∼2036) plus brevets de composition et de procédé.

3 Analyse quantitative

3.1 QUILT-2.005 : lecture bayésienne de l'intérim

QUILT-2.005 randomise ANKTIVA + BCG contre BCG seul chez 366 patients BCG-naïfs (cohorte A, recrutement clos en février 2026). En mars 2026, l'IDMC a examiné une analyse intermédiaire sur 183 patients évaluables et confirmé que la puissance était suffisante sans recrutement additionnel. Les taux de RC maintenue publiés sont de 85 % vs 57 % à 6 mois ($p = 0{,}054$) et 84 % vs 52 % à 9 mois ($p = 0{,}046$).

Reconstruction des effectifs

Les valeurs p publiées ne sont compatibles qu'avec de petits effectifs évaluables à 9 mois. Pour un test de Wald à deux proportions,

$$z = \frac{\hat{p}_A - \hat{p}_B}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})\left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}\right)}}, \qquad \bar{p} = \frac{x_A + x_B}{n_A + n_B},$$

$z \approx 2{,}0$ ($p = 0{,}046$) avec $\hat{p}_A - \hat{p}_B = 0{,}32$ impose $n \approx 20$ par bras. Nous retenons $x_A/n_A = 16/19$ (84,2 %) et $x_B/n_B = 11/21$ (52,4 %). **L'intérim est donc fondé sur une quarantaine de patients** : le signal est encourageant, mais fragile.

Avec un a priori uniforme, $p_A \sim \mathrm{Beta}(1+x_A, 1+n_A-x_A)$, $p_B \sim \mathrm{Beta}(1+x_B, 1+n_B-x_B)$ et $\Delta = p_A - p_B$ est estimé par Monte-Carlo (200 000 tirages).

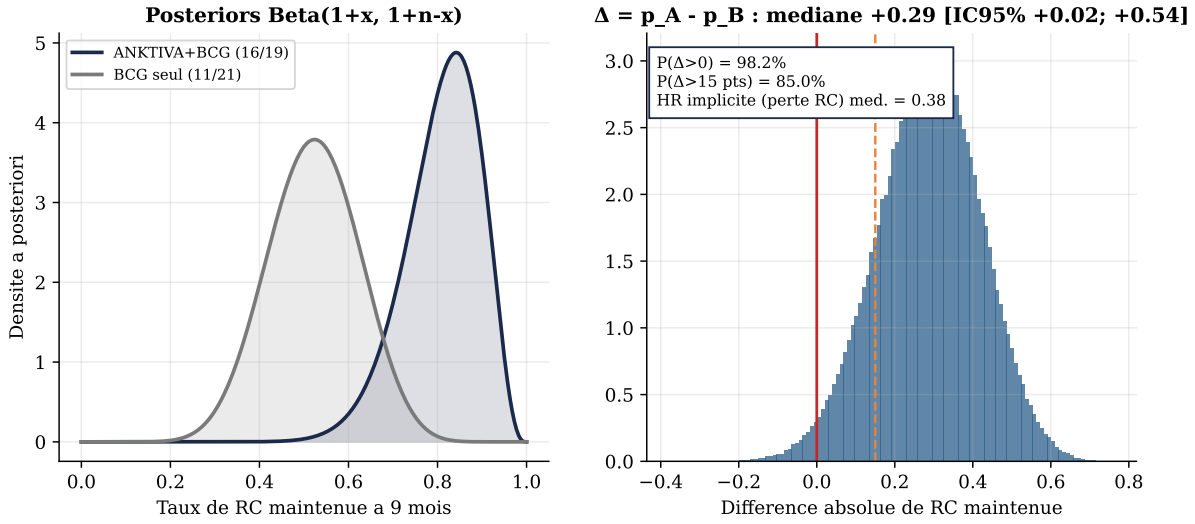


Figure 6 – Posterior bayésien de l'intérim QUILT-2.005. Gauche : lois a posteriori des taux de RC maintenue à 9 mois. Droite : distribution de Δ. Médiane +29 points, IC95 % crédible $[+2\,;\,+54]$; $P(\Delta > 0) = 98.2\,\%$, $P(\Delta > 15\text{ pts}) = 85\,\%$. Le « HR implicite » est le rapport des risques de perte de réponse $\frac{1-p_A}{1-p_B}$ (≈ 0.38). La largeur de l'intervalle (de quasi nul à +54 points) illustre l'incertitude résiduelle.

3.2 Puissance et probabilité de succès (PPoS)

La puissance d'un test bilatéral à $\alpha = 5\,\%$ pour deux proportions s'écrit :

$$1 - \beta = \Phi\left(\frac{|p_A - p_B| - z_{1-\alpha/2}\sqrt{2\bar{p}(1-\bar{p})/n}}{\sqrt{[p_A(1-p_A) + p_B(1-p_B)]/n}} \right).$$

Pour la PPoS, nous simulons 20 000 essais finaux ($n = 120$ évaluables par bras pour la RC maintenue, hypothèse) en tirant les vrais taux dans le posterior. Comme les effets d'intérim sont systématiquement surestimés (« winner's curse »), nous appliquons un rétrécissement de 50 % de Δ vers zéro : $p_A^* = p_B + 0{,}5(p_A - p_B)$.

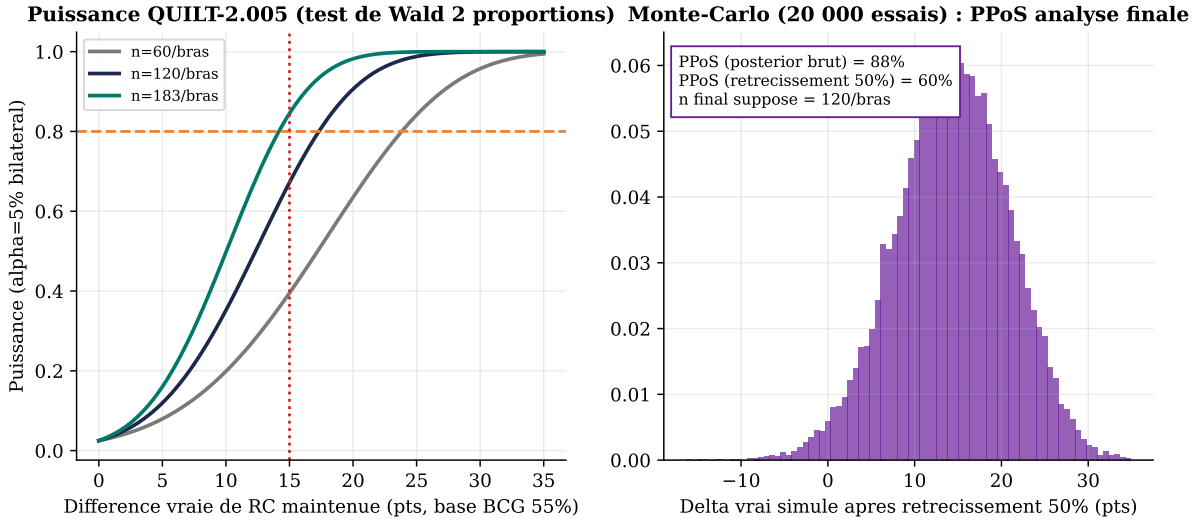


Figure 7 – Puissance et PPoS Monte-Carlo. Gauche : puissance en fonction de la différence vraie (base BCG 55 %) pour 60, 120 et 183 patients par bras ; avec 120/bras, une différence de 15 points est détectée avec ∼75–80 % de puissance. Droite : distribution du Δ vrai après rétrécissement. PPoS = 88 % avec le posterior brut, **60 %** après rétrécissement. Nous retenons $P(\text{approbation BCG-naïf}) = 60\,\%$ dans le modèle de base (PPoS × probabilité réglementaire conditionnelle $\approx 0{,}9$, arrondie à la hausse compte tenu de la décision papillaire).

Pourquoi l'endpoint compte

Le critère principal de QUILT-2.005 combine RC (CIS) et DFS (papillaire). La FDA a montré en 2025 qu'elle pouvait exiger une analyse *time-to-event* randomisée pour la DFS. Un résultat significatif sur la RC mais ambigu sur la DFS papillaire est le scénario intermédiaire le plus probable après le succès franc.

3.3 Sensibilité de la valorisation

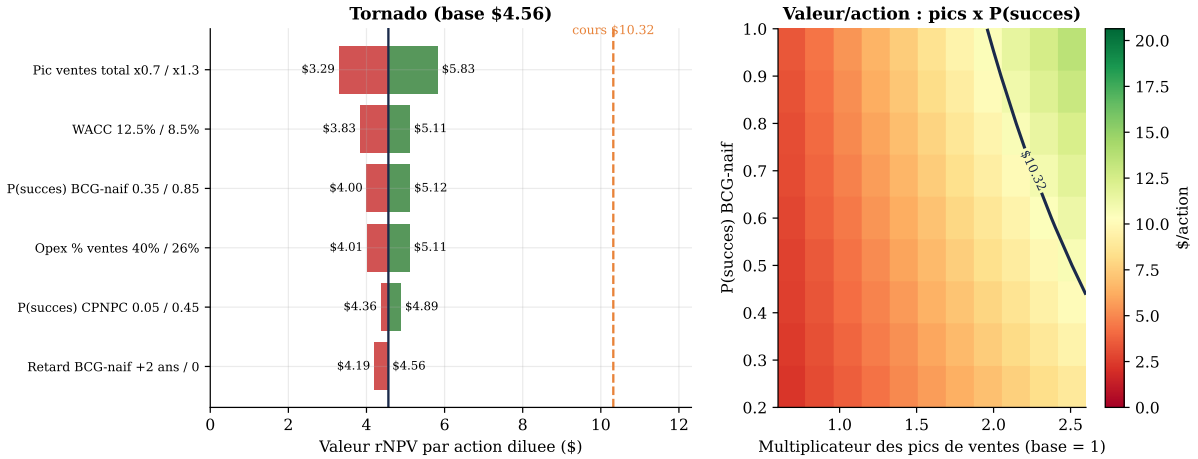


Figure 8 – Analyse de sensibilité. Gauche : tornado de la valeur rNPV par action diluée (base \$4.56) ; la variable dominante est le niveau des pics de ventes (±30 %), devant le WACC et la probabilité de succès en BCG-naïf. Aucune variation isolée raisonnable ne ramène la valeur au cours (\$10.32, ligne pointillée). Droite : carte de chaleur valeur/action selon le multiplicateur des pics (axe x) et P(succès BCG-naïf) (axe y) ; la courbe noire est l'isovaleur \$10.32 : il faut ∼2,0–2,4x nos pics *et* une forte probabilité de succès pour justifier le cours.

4 Marché & concurrence

Le cancer de la vessie touche ∼85 000 nouveaux patients par an aux États-Unis ; ∼75 % sont des NMIBC, dont environ la moitié à haut risque, traités en première intention par BCG. Environ 8 000 patients/an deviennent BCG-réfractaires. Le marché NMIBC est en pleine « révolution » : quatre produits approuvés en BCG-réfractaire depuis 2020 et trois nouveaux entrants attendus.

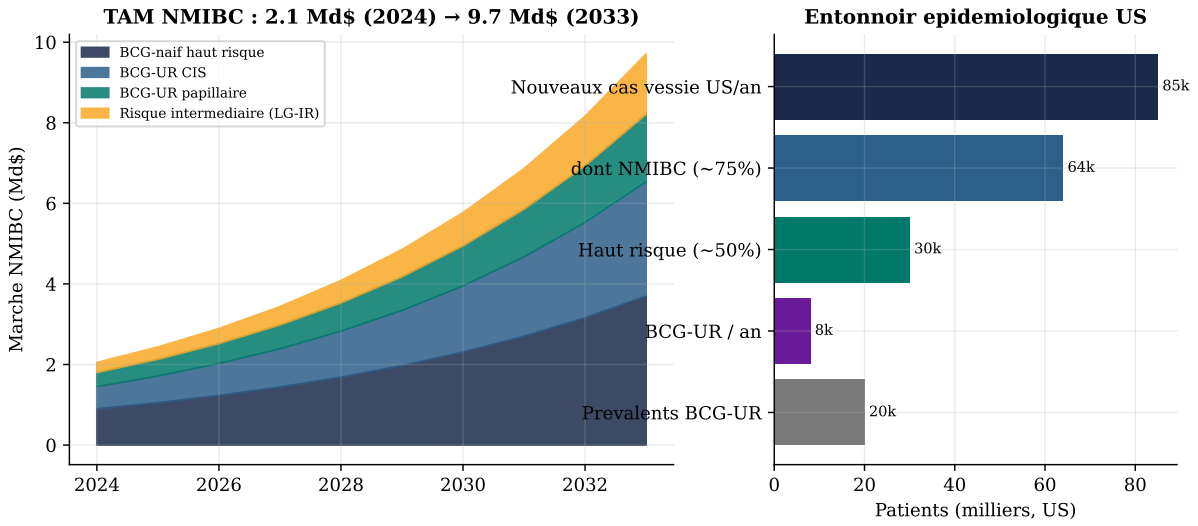


Figure 9 – **Marché adressable NMIBC.** Gauche : marché mondial par segment (hypothèses du modèle, TCAC 17–22 % par segment, de ∼2,1 Md$ en 2024 à ∼9,7 Md$ en 2033), porté par la substitution du BCG seul et des cystectomies par des immunothérapies intravésicales premium. Droite : entonnoir épidémiologique US (incidence ACS/SEER ; parts NMIBC et haut risque issues de la littérature urologique). Le segment BCG-naïf haut risque (∼30 000 patients/an) est 3–4x plus large que le BCG-réfractaire.

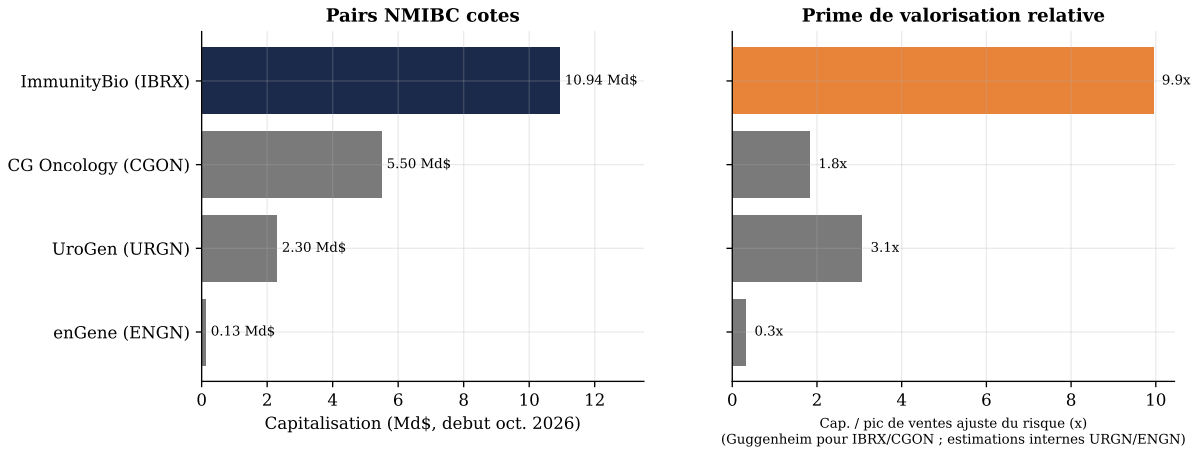


Figure 10 – **Comparables cotés NMIBC.** Gauche : capitalisation boursière début octobre 2026 (IBRX au 14/10 ; CG Oncology ∼5,5 Md$ au 07/10 ; UroGen ∼2,3 Md$ en août ; enGene ∼0,13 Md$). Droite : capitalisation rapportée au pic de ventes ajusté du risque (Guggenheim, « The NMIBC Revolution » : $1,1 Md pour ANKTIVA, $3,0 Md pour crétostimogène ; estimations internes pour UroGen et enGene). IBRX se paie ∼10x ce pic contre ∼2x pour CG Oncology, dont le produit affiche pourtant un meilleur taux de RC.

Table 3 – Positionnement concurrentiel en NMIBC BCG-réfractaire

Produit	Société	RC CIS	DoR méd.	Commentaire
ANKTIVA + BCG	ImmunityBio	62–71 %	26,6 m	Label CIS + papillaire ; dépendance BCG
Inlexzo (TAR-200)	J&J	82 %	25,8 m	Dispositif intravésical gemcitabine ; puissance commerciale J&J
Crétostimogène	CG Oncology	76 %	∼27 m	Adenovirus oncolytique ; BLA attendue fin 2026
Adstiladrin	Ferring	51 %	9,7 m	Thérapie génique IFN-α2b ; capacité limitée
Keytruda	Merck	41 %	16,2 m	Systémique ; toxicités immunitaires
Detalimogène	enGene	n.d.	n.d.	Non viral ; dépôt BLA visé 2026

Lecture concurrentielle

J&J dispose d'un produit plus efficace sur la RC et d'une force de vente sans commune mesure ; CG Oncology arrive avec 76 % de RC et un profil de tolérance favorable. La part de marché d'ANKTIVA en BCG-réfractaire CIS devrait plafonner autour de 25–35 %, d'où un pic de $650 M dans notre cas central pour ce segment.

5 Analyse M&A

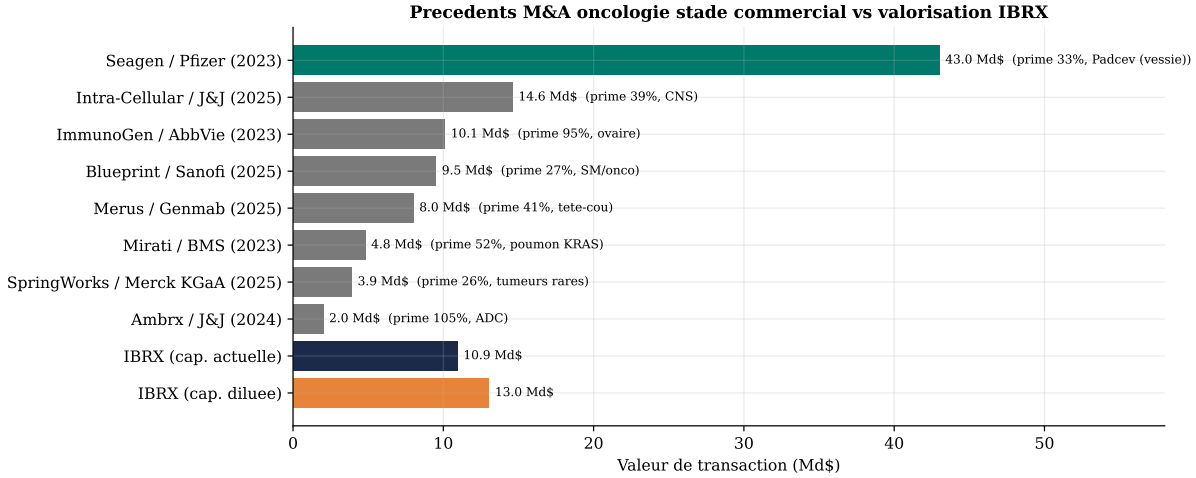


Figure 11 – Précédents M&A en oncologie (stade commercial ou pivot) vs IBRX. Valeurs de transaction et primes sur cours non affecté : Pfizer/Seagen 43 Md$ (33 %, Padcev en uróthélial), J&J/Intra-Cellular 14,6 Md$ (SNC, référence de taille), AbbVie/ImmunoGen 10,1 Md$ (95 %), Sanofi/Blueprint 9,5 Md$ (27 %), Genmab/Merus 8,0 Md$ (41 %), BMS/Mirati 4,8 Md$ (52 %), Merck KGaA/SpringWorks 3,9 Md$ (26 %), J&J/Ambrx 2,0 Md$ (105 %). Avec 13 Md$ de capitalisation diluée, un rachat d'IBRX à +30 % ($13.42/action, ∼17 Md$) se situerait dans le haut de la distribution, juste derrière Seagen, pour un actif dont les ventes annuelles sont ∼10x inférieures.

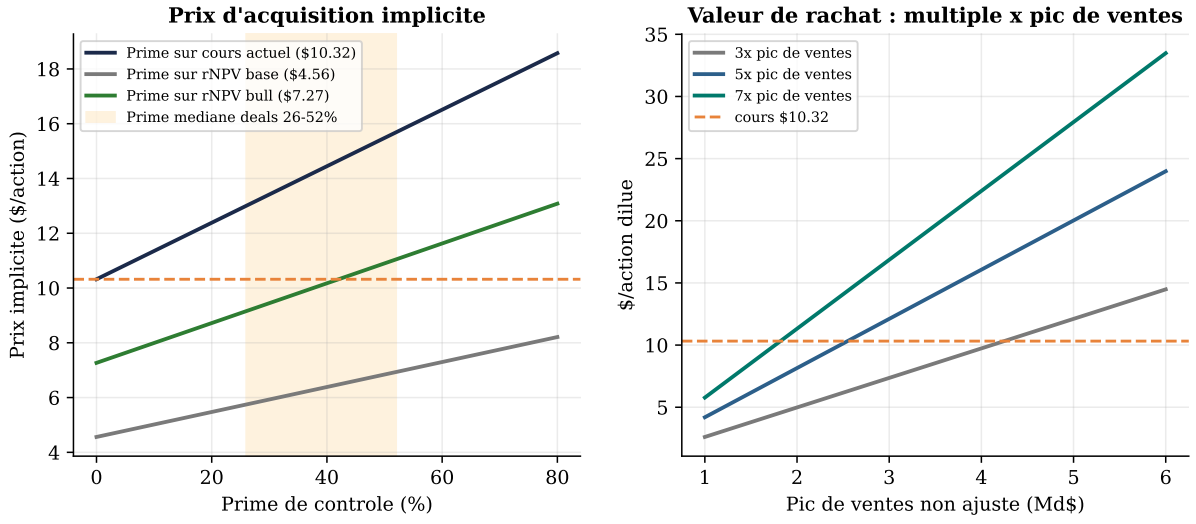


Figure 12 – Analyse de prime. Gauche : prix d'acquisition implicite selon la prime de contrôle, appliquée au cours ($10.32), à la rNPV de base ($4.56) et à la rNPV bull ($7.27) ; la bande dorée couvre la prime médiane des deals (26–52 %). Un acquéreur valorisant ANKTIVA sur notre cas bull paierait au mieux ∼$10–11, soit environ le cours actuel. Droite : valeur par action diluée selon un multiple de 3x/5x/7x le pic de ventes non ajusté ; il faut ≥$2,5 Md de pic à 5x pour justifier le cours.

Table 4 – Acquéreurs potentiels

Acquéreur	Rationnel	Probabilité
Merck & Co	Falaise Keytruda 2028 ; déjà fournisseur unique du BCG TICE ; combinaison IL-15 + anti-PD-1	Moyenne
AstraZeneca	Franchise urologique (Imfinzi NIAGARA/POTOMAC) ; volonté d'entrer en intravésical	Moyenne
Pfizer	Padcev/Seagen en urothélial avancé ; manque d'actif NMIBC	Faible–moyenne
Ferring	Leader historique urologie, Adstiladrin sous-dimensionné	Faible (taille)
Johnson & Johnson	Déjà positionné (Inlexzo) — risque antitrust	Faible

Similarité deal par deal (3 plus proches)

1. Pfizer/Seagen (2023) — similarité élevée sur la franchise vessie et la croissance ; mais Seagen réalisait ∼2,2 Md$ de ventes (VE/ventes ∼20x) contre 54x pour IBRX.
2. Sanofi/Blueprint (2025) — produit unique en lancement (Ayvakit) avec extension vers une population plus large : profil comparable à ANKTIVA → BCG-naïf. Prime de 27 %, VE/ventes ∼15x.
3. Merck KGaA/SpringWorks (2025) — biotech commerciale récente, deux produits en lancement, 3,9 Md$ (26 %). Encadre ce que le marché paie pour un actif dérisqué de niche.
Conclusion : les multiples récents (15–20x ventes) appliqués aux ventes 2027E ($354 M) donnent 5–7 Md$ de VE, soit la moitié de la valeur actuelle.

Frein structurel au M&A

Le Dr Patrick Soon-Shiong et ses entités affiliées contrôlent la majorité du capital et sont créanciers via la note convertible. Aucune opération n'est possible sans leur accord ; l'historique (NantKwest, NantHealth) suggère une préférence pour l'indépendance. Nous limitons la probabilité de rachat à 8 % sur 24 mois.

6 Financials

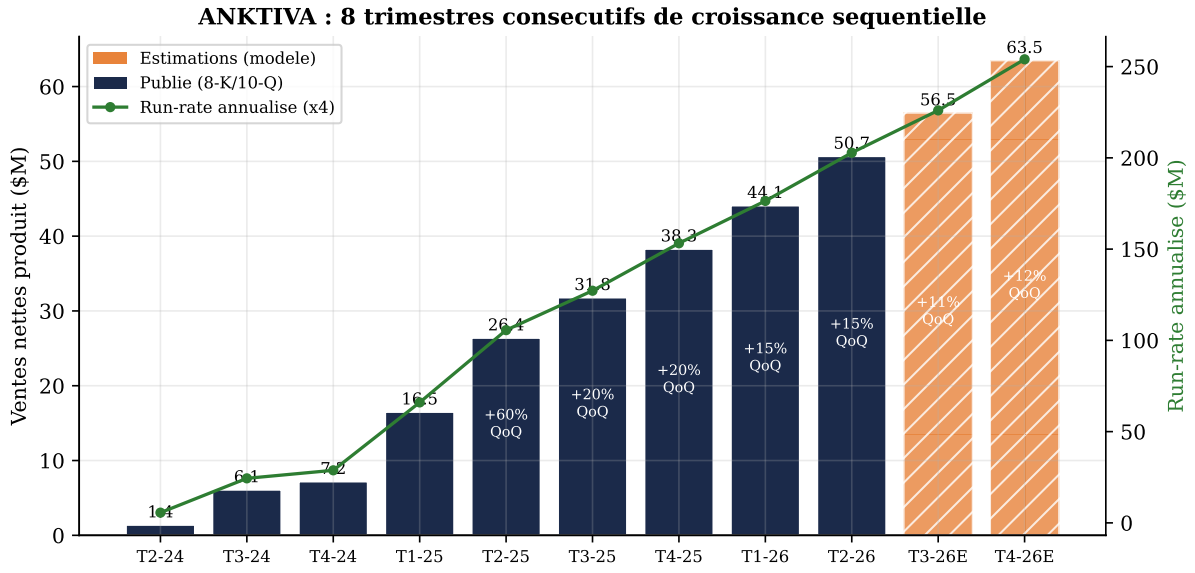


Figure 13 – **Ventes nettes produit trimestrielles.** Barres pleines : publiées (8-K/10-Q ; T1-25 et T4-24 déduits des cumuls semestriels/annuels). Barres hachurées : estimations du modèle pour T3/T4-2026 ($56,5 M et $63,5 M, +11–12 % séquentiel, incluant un début de contribution du label papillaire en décembre). Courbe verte : run-rate annualisé, ∼$250 M en fin d'année. La décélération de la croissance séquentielle (+60 % → +15 %) est normale pour un lancement de 2 ans mais mérite d'être suivie face à l'arrivée d'Inlexzo.

Table 5 – Compte de résultat résumé ($M ; 2024–2025 publiés, 2026–2027 estimés)

$M	2024A	2025A	S1-26A	2026E	2027E
Ventes nettes produit	14,7	113,0	94,8	215	354
Croissance a/a	n.s.	+669 %	+121 %	+90 %	+65 %
Marge brute (est.)	n.s.	~85 %	~88 %	~88 %	~90 %
Perte opérationnelle	(~380)	(~290)	(131,5)	(~250)	(~140)
Charges financières / juste valeur	(~35)	(~60)	(~170)*	variable	variable
Perte nette (GAAP)	(414)	(~351)	n.d.	n.s.	n.s.
Cash consommé (opérations)	(~380)	(~330)	(141,9)	(~255)	(~130)
Actions moyennes (M)	~690	~920	1 055	1 060	1 075

*T2-26 seul : autres charges nettes de $168,7 M, essentiellement non monétaires (réévaluation de la note convertible et des warrants à la juste valeur, la hausse du cours augmentant le passif). Les montants marqués ~ sont des ordres de grandeur issus d'agrégateurs (TTM) et doivent être recoupés avec le 10-K 2025.

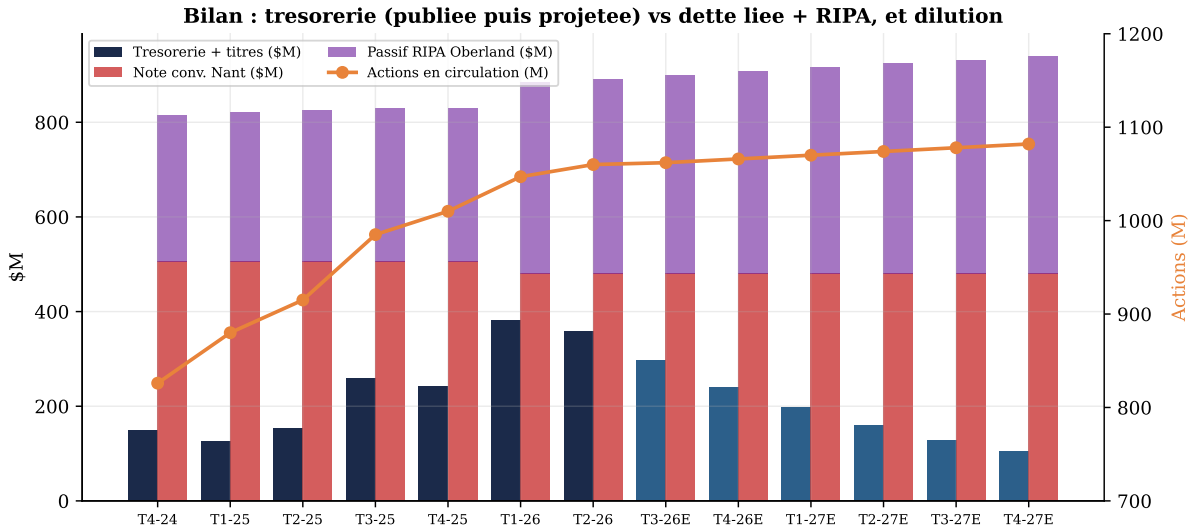


Figure 14 – **Trésorerie, dette liée et dilution.** Trésorerie publiée (31/12/2025 : $242,8 M ; 31/03/2026 : $380,9 M ; 30/06/2026 ; points intermédiaires 2024–2025 approximatifs) jusqu'au 30/06/2026 ($357.4 M, après le financement de $100 M de mars dont $75 M de RIPA et $25 M de conversion de dette Nant), puis projetée (barres hachurées) avec un burn trimestriel décroissant de ~$62 M à ~$25 M au fil de la montée des ventes. La trésorerie tomberait à ~$103 M fin 2027 : **un refinancement est probable avant le T1-28E**, sauf accélération des ventes. Le passif (note Nant + RIPA) dépasse $880 M ; le nombre d'actions est passé de 826 M à 1 060 M en 18 mois.

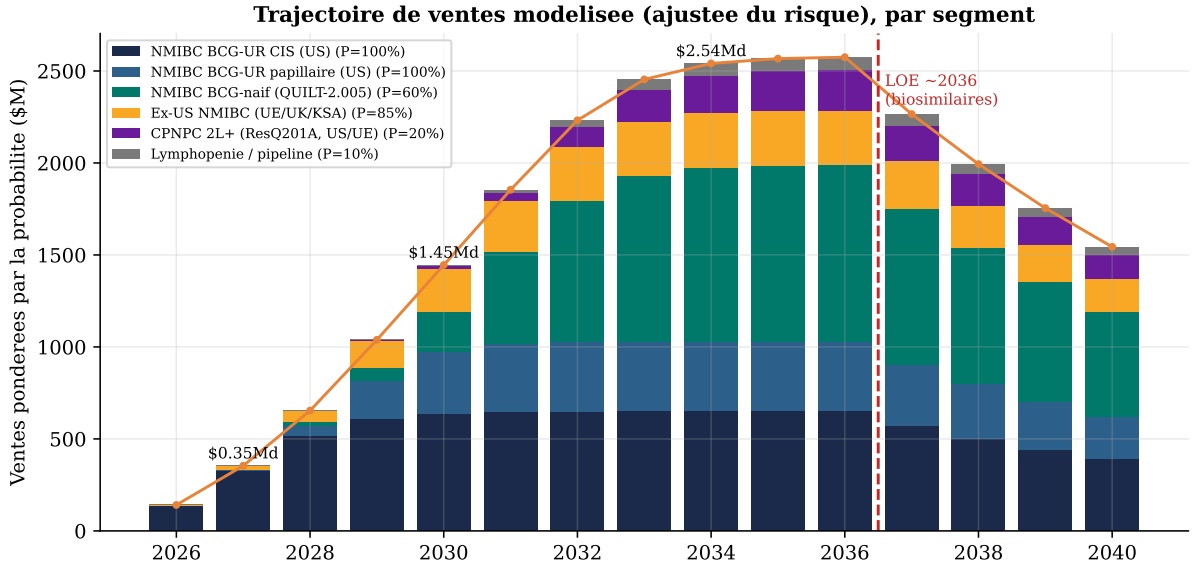


Figure 15 – **Trajectoire de ventes ajustée du risque par segment.** Courbes d'adoption logistiques $S_i(t) = \dfrac{\text{Pic}_i}{1+e^{-k_i(t-t_{\text{mid},i})}}$ avec $k_i = 8/(t_{\text{pic}} - t_{\text{lancement}})$, pondérées par P_i. Ventes ajustées : \$354 M en 2027, \$1.45 Md en 2030, \$2.54 Md en 2034. Perte d'exclusivité modélisée en 2036 avec érosion de 12 %/an (biosimilaires intravésicaux lents à se développer).

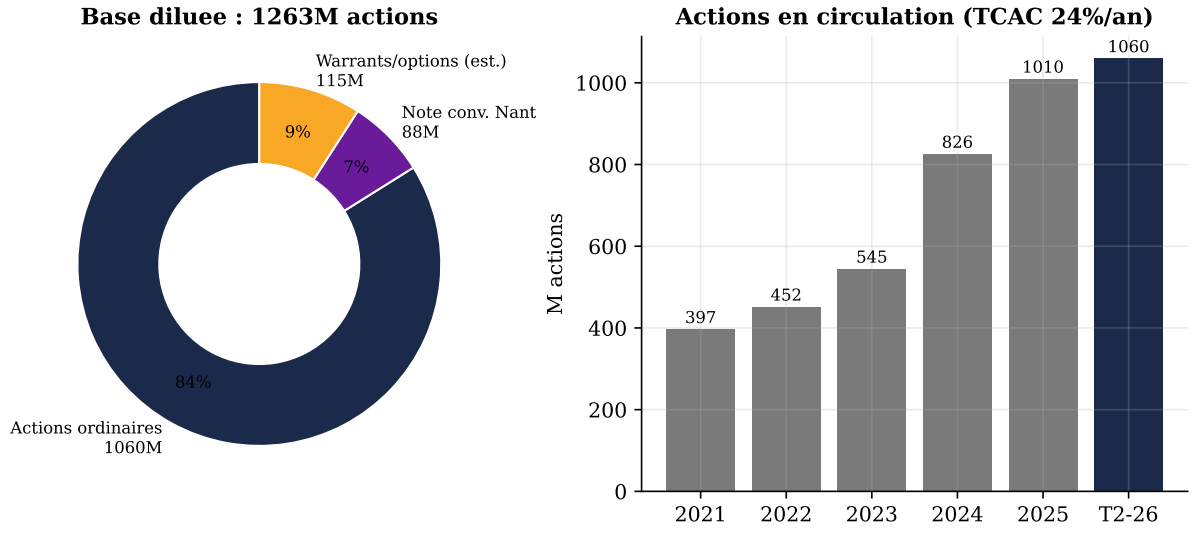


Figure 16 – **Structure du capital et dilution historique.** Gauche : base diluée estimée de 1,263 M actions = 1,060 M ordinaires + 88.4 M sous-jacentes à la note Nant (\$480 M / \$5,427) + ∼115 M warrants et options dans la monnaie (estimation à partir des financements 2024–2025). Droite : nombre d'actions en circulation (fin de période, approximations 10-K/10-Q sauf T2-26) ; TCAC de 24 %/an depuis 2021.

7 Valorisation

7.1 Méthodologie rNPV

Pour chaque segment i (pic de ventes Pic_i, probabilité P_i), la contribution actualisée est :

$$\text{rNPV}_i = \sum_{t=2027}^{2040} \frac{P_i \, S_i(t) \, m_i \, (1-\tau_t)}{(1+r)^{t+0{,}5-t_0}} + \frac{P_i \, S_i(2040) \, m_i \, (1-\tau) \, (1-g)}{(r+g)\,(1+r)^{2040{,}5-t_0}},$$

avec $m_i = \text{MB} - \rho - \text{opex} = 0{,}90 - 0{,}075 - 0{,}33 = 49{,}5\,\%$ (US) ou 30 % (ex-US via partenaires), ρ la redevance Oberland, $r = 10.0\,\%$, $g = 10\,\%$ de déclin terminal, τ_t l'impôt effectif après utilisation de ∼\$3 Md de déficits

reportables, $t_0 = 2026{,}8$. Puis :

$$\text{VE} = \sum_i \text{rNPV}_i - \text{PV(overhead)}, \qquad \text{Valeur/action} = \frac{\text{VE} + \text{Trésorerie}}{N_{\text{dilué}}}.$$

La note Nant, profondément dans la monnaie, est traitée comme convertie (actions incluses dans $N_{\text{dilué}}$) ; la redevance Oberland est déduite des marges, le passif RIPA n'est donc pas soustrait une seconde fois.

Table 6 – Hypothèses et résultats par segment (cas de base)

Segment	Lanc.	Pic	Pic $M	P_i	rNPV $M	$/act.
NMIBC BCG-réfr. CIS (US)	2024	2030	650	100 %	2,095	1.66
NMIBC BCG-réfr. papillaire (US)	2026	2031	380	100 %	969	0.77
NMIBC BCG-naïf (QUILT-2.005)	2028	2034	1 600	60 %	1,774	1.40
Ex-US NMIBC (UE/UK/KSA/EAU)	2026	2032	350	85 %	454	0.36
CPNPC 2L+ (ResQ201A)	2029	2035	1 100	20 %	339	0.27
Lymphopénie / pipeline	2029	2035	700	10 %	108	0.09
Overhead plateforme ($70 M/an 2027–31)					-273	
Trésorerie estimée 30/09/2026					295	
Valeur des fonds propres					**5,762**	**4.56**

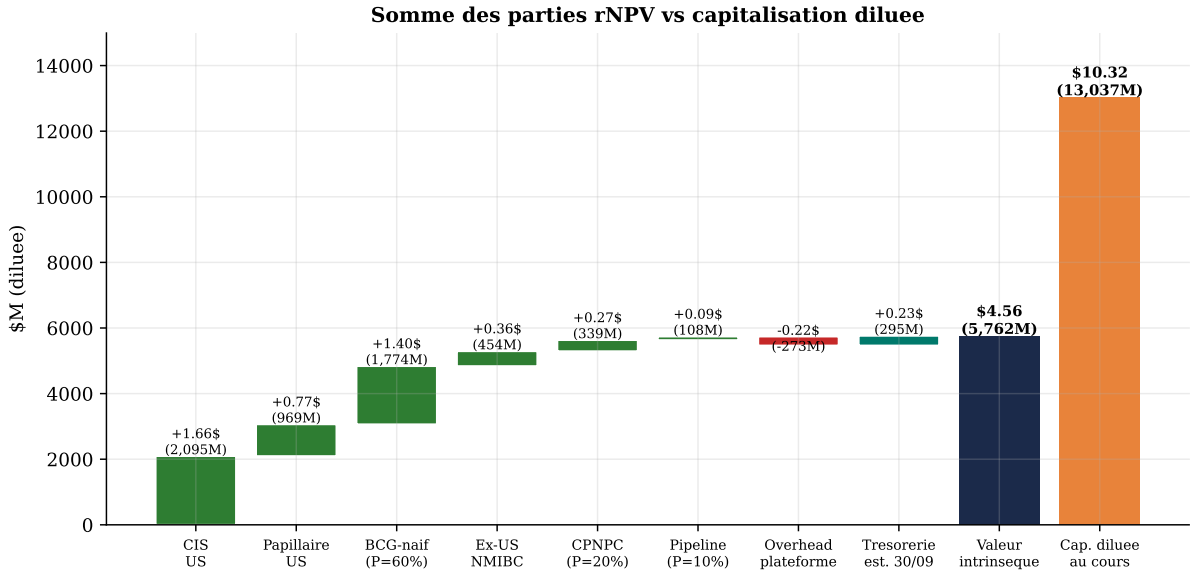


Figure 17 – **Somme des parties rNPV (cas de base) vs capitalisation diluée.** Les deux indications déjà approuvées aux États-Unis (CIS + papillaire) valent $2,43/action ; l'option BCG-naïf $1,40 ; le reste (ex-US, poumon, pipeline) moins de $0,75. La valeur intrinsèque ($4.56, 5,762 M$) représente ∼44 % de la capitalisation diluée au cours de $10.32.

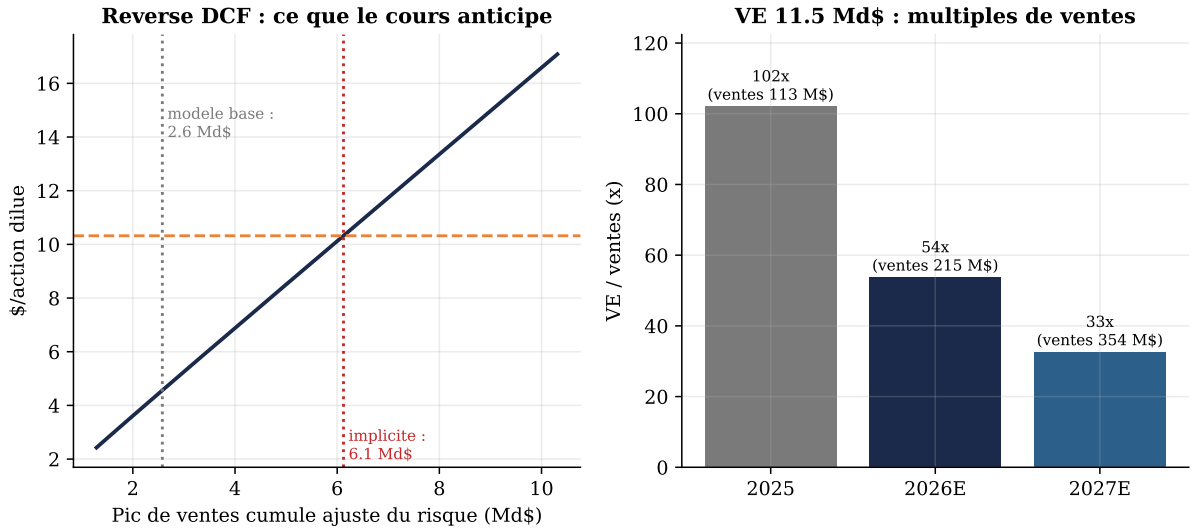


Figure 18 – **Ce que le cours anticipe.** Gauche : reverse DCF — valeur par action en fonction du pic de ventes cumulé ajusté du risque (toutes économies unitaires inchangées). Le cours de \$10.32 correspond à ∼\$6,1 Md de pic ajusté, soit 2.38x notre cas central (\$2.58 Md). Droite : VE/ventes de 102x (2025), 54x (2026E) et 33x (2027E) — des multiples réservés d'ordinaire aux plateformes à très forte croissance.

7.2 Scénarios probabilisés

Chaque scénario est calculé par le même modèle en modifiant les paramètres (pics, probabilités, WACC, opex, retards) ; le scénario M&A applique une prime de 30 % au cours.

$$\mathbb{E}[V] = \sum_s \pi_s V_s = 0.17 + 0.69 + 1.51 + 1.31 + 0.74 + 1.07 = \mathbf{\$5.49}, \qquad \frac{\mathbb{E}[V]}{\text{Cours}} - 1 = \mathbf{-47\,\%}.$$

Table 7 – Scénarios (valeur par action diluée, fourchette ±20 %)

Scénario	Prob.	Valeur	Contrib.	Hypothèses clés
Catastrophe	12 %	\$1.42	\$0.17	QUILT-2.005 négatif ; pics ×0,55–0,6 ; opex 40 % ; WACC 12 %
Bear	23 %	\$3.02	\$0.69	BCG-naïf retardé d'un an ($P = 35\,\%$) ; pics ×0,8
Base	33 %	\$4.56	\$1.51	Modèle central (tableau précédent)
Bull	18 %	\$7.27	\$1.31	BCG-naïf approuvé 2027 ($P = 85\,\%$) ; pics ×1,2–1,35 ; WACC 9,5 %
Blue sky	6 %	\$12.25	\$0.74	Plateforme IL-15 validée (CPNPC US 60 %, lymphopénie 35 %) ; pics ×1,4–1,9
M&A	8 %	\$13.42	\$1.07	Rachat à +30 % (accord Soon-Shiong requis)
Espérance	**100 %**		**\$5.49**	**-47 % vs \$10.32**

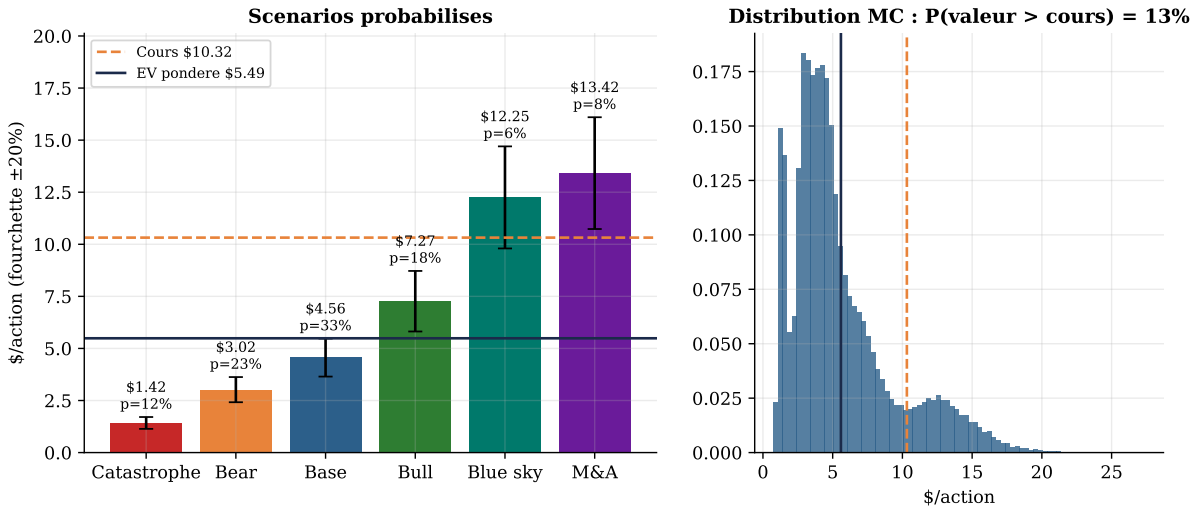


Figure 19 – **Scénarios probabilisés.** Gauche : valeur par scénario avec fourchette ±20 % et probabilité ; ligne orange = cours, ligne bleue = espérance pondérée ($5.49). Droite : distribution Monte-Carlo (50 000 tirages : choix du scénario selon π_s, puis bruit lognormal $\sigma = 0{,}18$). $P(\text{valeur} > \text{cours}) = 13\,\%$: seuls les scénarios Blue sky et M&A dépassent le cours actuel.

Ce qui ferait de nous des acheteurs

(i) Topline QUILT-2.005 avec $\Delta \geq 20$ points sur la RC *et* la DFS ; (ii) ventes trimestrielles >$80 M dès le T2-2027 (preuve que le papillaire et l'ex-US s'additionnent) ; (iii) résolution durable de l'approvisionnement rBCG ; (iv) un repli du cours vers $6–7 sans dégradation fondamentale.

8 Risques

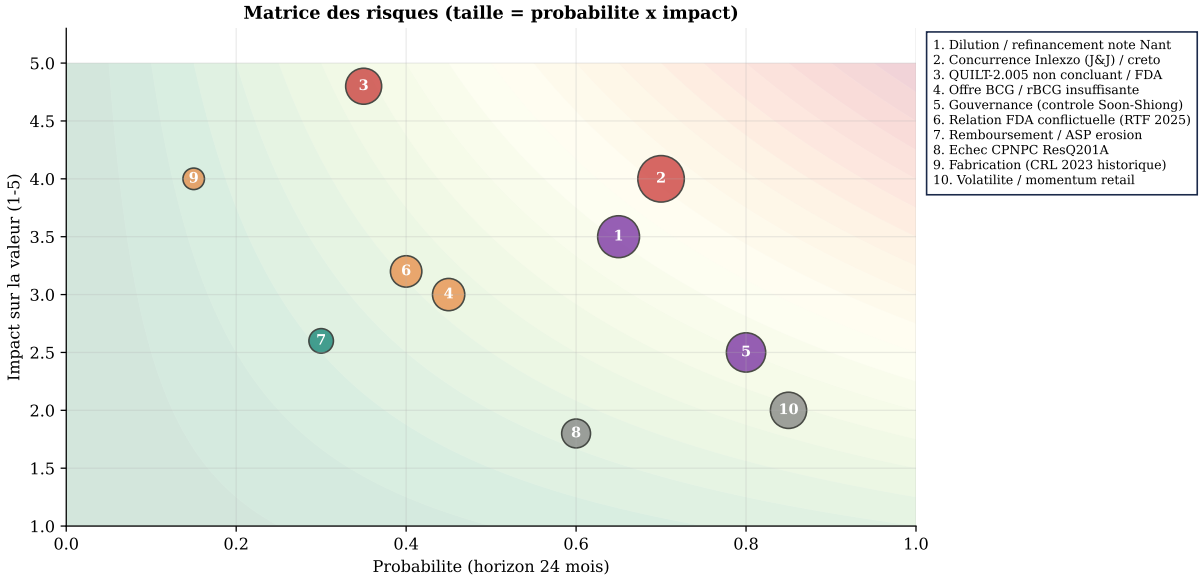


Figure 20 – **Matrice des risques (horizon 24 mois).** Axe x : probabilité de matérialisation ; axe y : impact sur la valeur (1 = négligeable, 5 = destruction de la thèse) ; taille des bulles $\propto$ probabilité $\times$ impact. Couleurs : rouge = clinique/concurrentiel, violet = financier/gouvernance, orange = opérationnel/réglementaire, gris = marché. Les risques les plus lourds sont la concurrence d'Inlexzo/crétostimogène (2), la dilution (1) et l'issue de QUILT-2.005 (3).

Bear case détaillé

1. **Valorisation** : 54x les ventes 2026E ; le cours intègre 2.38x notre pic ajusté. Une simple normalisation à 15–20x les ventes 2027E impliquerait \$4–6.
2. **Concurrence** : Inlexzo (RC 82 %, J&J) et crétostimogène (76 %, BLA fin 2026) visent les mêmes urologues ; la croissance séquentielle d'ANKTIVA est déjà passée de +60 % à +15 %.
3. **QUILT-2.005** : intérim sur ∼40 patients, p à la limite (0,046–0,054) ; PPoS ≈ 60 %. Un échec retirerait ∼\$1,4/action de valeur et probablement 40–50 % du cours.
4. **Dilution** : 826 M → 1 060 M actions en 18 mois ; trésorerie projetée à ∼\$103 M fin 2027 ; nouvelle levée ou tirage RIPA probable avant le T1-28E.
5. **Structure financière** : note Nant de \$480 M (refinancement incertain, conditions à la discrétion de l'actionnaire de contrôle) et redevance de 5,6–12,5 % des ventes jusqu'au cap Oberland.
6. **Gouvernance** : contrôle majoritaire de P. Soon-Shiong, transactions avec parties liées (Nant, PDS Biotechnology), communication promotionnelle ; minoritaires sans levier.
7. **Approvisionnement BCG** : TICE (Merck) fournisseur unique US, rationné depuis 2019 ; le rBCG Serum Institute n'est disponible qu'en accès élargi — contrainte directe sur le segment BCG-naïf.
8. **FDA et volatilité** : historique de CRL (2023) et de RTF (2025) ; titre très détenu par le retail (19,7 M de titres échangés le 14/10), drawdowns de 40 % fréquents (février–mars 2026).

9 Catalyseurs

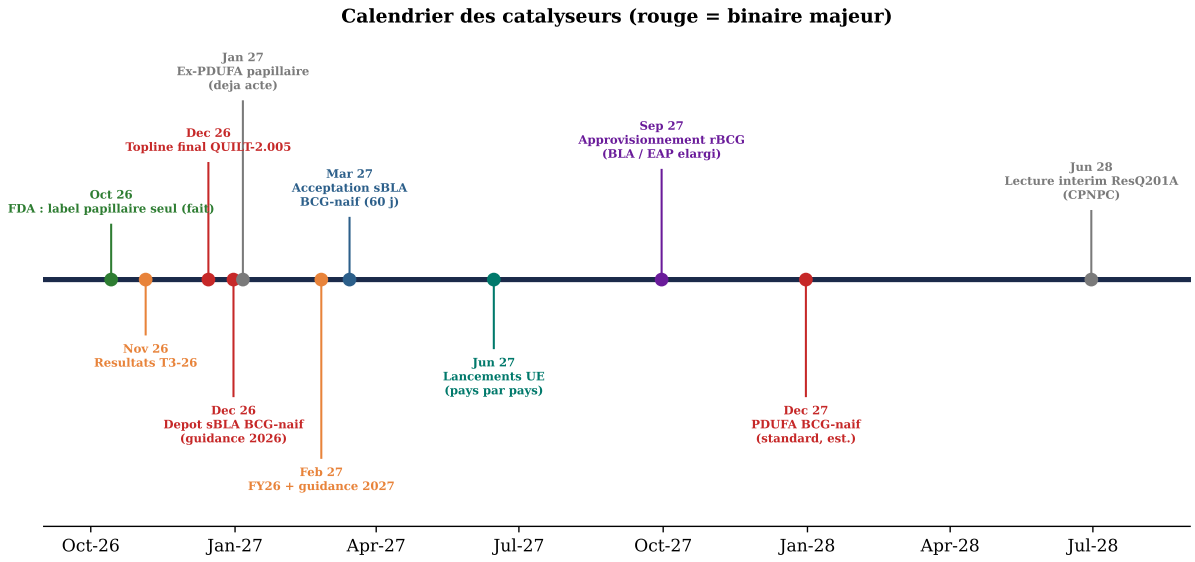


Figure 21 – Calendrier des catalyseurs 2026–2028. En rouge, les événements binaires majeurs : topline final de QUILT-2.005 et dépôt de la sBLA BCG-naïf (guidance 2026), puis la décision PDUFA estimée fin 2027 (revue standard de 10 mois après acceptation). Le PDUFA papillaire du 6/1/2027 est devenu sans objet après l'approbation anticipée du 14/10/2026. Dates postérieures à 2026 = estimations.

Table 8 – Calendrier des catalyseurs et impact attendu

Date	Événement	Impact	Binaire
14/10/2026	FDA : label papillaire seul (acquis)	+ (intégré)	Non
Déb. nov. 2026	Résultats T3-2026 (consensus implicite ∼$55–58 M)	±10 %	Non
T4-2026	Topline final QUILT-2.005 (RC + DFS, BCG-naïf)	±35–50 %	**Oui**
Fin 2026	Dépôt sBLA BCG-naïf	+	Partiel
Fév. 2027	FY2026 + guidance 2027 ; trajectoire de burn	±10 %	Non
T1-2027	Acceptation sBLA (priorité ou standard)	±10 %	Partiel
2027	Lancements UE pays par pays ; prix et remboursement	+	Non
2027	BLA rBCG / extension de l'accès élargi	+	Partiel
Fin 2027 (est.)	PDUFA BCG-naïf	±25–40 %	**Oui**
2028	Interim ResQ201A (CPNPC)	±15 %	**Oui**
Continu	Financement / refinancement note Nant	−5 à −15 %	Non

Insiders & analystes

Analystes : 6–7 couvertures, consensus « Buy » ; objectif moyen $12,6 (StockAnalysis, fourchette $7–23) à $14,2 (MarketBeat) ; HC Wainwright $15 (juin 2026), BTIG $12 (mai 2026), D. Boral $23. Weiss Ratings : Sell. Les objectifs impliquent +22 à +38 % mais reposent sur des pics de ventes multi-milliards non ajustés du risque.
Insiders : pas d'achat significatif identifié en 2026 ; vente de 25 000 titres par l'administratrice C. Selecky (23/02/2026). L'actionnaire de contrôle a converti $25 M de dette en 4,6 M d'actions en mars 2026 ($5,43), un signal de confiance mais à un prix très inférieur au cours.

10 Conclusion

ImmunityBio n'est plus une histoire de R&D : ANKTIVA est un produit commercial en croissance, dont le label vient d'être élargi par la FDA sans essai supplémentaire, avec un essai randomisé pivot déjà recruté dans le plus grand segment du NMIBC. Mais le marché a anticipé ce succès : à $10.32, l'action valorise l'entreprise à $11.5 Md de VE, soit 54x les ventes 2026E et ∼2,3x notre valeur intrinsèque de base. Même notre scénario bull ($7.27) reste sous le cours ; seuls une validation de la plateforme IL-15 au-delà de la vessie ou un rachat à prime justifient les niveaux actuels.

Verdict final

Cours (14/10/2026)	$10.32
rNPV cas de base	$4.56
Valeur pondérée des scénarios	**$5.49**
Potentiel	**-47 %**
P(valeur > cours) (Monte-Carlo)	13 %
Recommandation	**NEUTRE / SOUS-PONDÉRER**

Position sizing : 0 % en cœur de portefeuille. Exposition spéculative plafonnée à 0,5–1 % du portefeuille pour les investisseurs souhaitant jouer QUILT-2.005, idéalement via des structures à risque défini (call spreads) plutôt qu'en actions. Pour les détenteurs : prise de bénéfices partielle ou couverture (puts) avant le topline. Niveau d'achat réévalué : ≤$6 (proche de la valeur bull actualisée avec marge de sécurité) ou après un succès franc de QUILT-2.005.

Sources

1. ImmunityBio, 10-Q T2-2026 (SEC, 0001326110-26-000079) et 10-Q T1-2026 ; 10-K FY2025.
2. ImmunityBio, 8-K / communiqué « Record Q2 2026 Net Product Revenue of $50.7 Million », 04/08/2026 (BusinessWire).
3. ImmunityBio, « Net Product Revenue … Record $44 Million in Q1 2026 and $381 Million in Cash », 09/04/2026.
4. ImmunityBio, « $113 Million of Preliminary Net Product Revenue », 15/01/2026 ; résultats FY2025, 23/02/2026.
5. ImmunityBio, « Strengthens Balance Sheet with $100 Million of Financing Transactions », 31/03/2026.
6. ImmunityBio, acceptation de la sBLA papillaire (PDUFA 06/01/2027), 19/05/2026 ; resoumission, 09/03/2026.

7. FiercePharma, « FDA clears ImmunityBio's Anktiva expansion in bladder cancer after regulatory whiplash », 14/10/2026 ; Benzinga, 14/10/2026.
8. ImmunityBio, « Confirms Statistical Power in Pivotal Randomized BCG-Naïve NMIBC Trial », 26/03/2026 ; *Urology Times*.
9. Commission européenne (autorisation conditionnelle, févr. 2026) ; SFDA (CPNPC + NMIBC, janv. 2026) ; EMA EPAR Anktiva.
10. Guggenheim Securities, « Biopharma : The NMIBC Revolution ».
11. StockAnalysis, MarketBeat/Defense World (16/09/2026), Tickernerd (23/09/2026) : objectifs d'analystes.
12. Pitchbook / Simply Wall St (CGON, 07/10/2026) ; StockAnalysis (ENGN, 02/10/2026) ; Walnut/Yahoo (URGN, août 2026).
13. Communiqués des acquéreurs : Pfizer/Seagen, AbbVie/ImmunoGen, BMS/Mirati, J&J/Ambrx, Sanofi/Blueprint, Merck KGaA/SpringWorks, Genmab/Merus, J&J/Intra-Cellular.
14. Publications pivotales : QUILT-3.032 (Chamie et al., *NEJM Evidence* ; *J. Urol.*), SunRISe-1, BOND-003, KEYNOTE-057, essai de phase 3 nadofáragène.